

12 - 01- Révision de la Sémiologie gynécologique - Pr. ABOULFALAH

(0:04 - 2:11)

Bonjour tout le monde, c'est docteur Aboul Falah, donc on va faire une révision sur les syndromes en gynécologie et je préfère vous présenter des cas cliniques, comme ça vous serez beaucoup plus aptes, ça va vous aider à répondre au cours de l'examen. Donc le premier cas clinique, il s'agit d'une patiente âgée de 35 ans qui est célibataire et qui a un antécédent de grossesse, d'interruption volontaire de grossesse. 35 ans, célibataire, notion d'interruption volontaire de grossesse, il y a un an, et qui consulte en urgence pour un saignement vaginal apparu depuis 48 heures, après un retard de règle de six semaines.

Au cours de l'anamnèse, on note l'absence d'algues pélviques ou de signes digestifs ou urinaires. Donc devant ce tableau clinique, quelles sont les causes possibles à ce saignement vaginal? Il y a plusieurs réponses, donc ça fait partie des ménométrorragies. Là, c'est une patiente qui est en période d'activité génitale, qui est célibataire avec notion d'interruption volontaire de grossesse et qui, en état d'urgence, consulte parce qu'il y a un saignement qui est apparu 48 heures après un retard de règle de six semaines.

Il n'y a pas d'algues pélviques ou de signes digestifs ou urinaires. Donc là, en fait, c'est des métrorragies qui apparaissent après un retard de règle chez une femme en période d'activité génitale. Donc la première proposition, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? D'abord, un cancer de l'endomètre.

(2:13 - 3:30)

Alors là, le cancer de l'endomètre, c'est un cancer qui apparaît après la ménopause, donc il est très fréquent après la ménopause, donc la réponse est fausse. Un avortement clandestin, parce qu'elle a déjà fait une interruption volontaire de grossesse, elle ne prend pas de pilules, donc cette proposition est vraie. Donc il faut entourer un avortement clandestin.

Puis une grossesse extra-utérine, donc la grossesse extra-utérine, les meilleurs symptômes, c'est le saignement, le retard de règle et la douleur. Mais un seul signe a permis quand même d'aller chercher s'il y a une grossesse extra-utérine. En plus, il y a une urgence vitale, donc il ne faut pas passer à côté de l'analyse diagnostique.

Donc chaque fois qu'il y a un signe gynécologique sur une femme en période d'activité génitale, il faut évoquer la grossesse extra-utérine. Donc il faut entourer la grossesse extra-utérine. S'il vous plaît, monsieur, même en l'absence de douleur pelvienne, on va le chercher.

(3:31 - 4:38)

Même en l'absence de douleur pelvienne, même en l'absence de saignement, à chaque fois qu'il y a un signe gynécologique, il faut évoquer ce diagnostic. Pourquoi ? Parce que c'est une

urgence vitale, ça peut entraîner la mort. Donc c'est pourquoi il faut toujours éliminer la grossesse, au moins faire un test de grossesse pour éliminer une grossesse parce qu'elle représente une véritable urgence.

Est-ce que c'est clair ? Mais le tableau typique n'existe que dans 30% des cas. Le tableau typique, c'est le retard de règle, l'hémétroragie et les algies pelviennes. C'est le tableau typique.

Mais il y a des tableaux atypiques où il y a très peu de signes et risque de rupture de cette grossesse extra-utérine avec un état de choc hémorragique, voire la mort. Donc c'est pourquoi tous les signes gynécologiques, il faut évoquer la grossesse extra-utérine. Oui ? C'est bon ? C'est bon, merci beaucoup.

(4:40 - 5:17)

Alors la quatrième proposition, c'est une molle idatiforme, c'est des grossesses particulières, c'est une dégénérescence du trophoblaste. Et là aussi, il y a des signes sympathiques de grossesse qui sont beaucoup plus prononcés, l'hémétroragie et le diagnostic qui l'est fait par le dosage de bêtas ACG qui sont très élevés, et l'aspect typique à l'échographie. Donc il peut être responsable aussi de saignement après un retard de règle.

(5:17 - 5:30)

C'est la molle idatiforme, donc il faut l'entourer. Et puis en dehors de la grossesse, il y a le cancer du colutérin. Alors le cancer du colutérin touche la femme à tous les âges.

(5:31 - 5:44)

Donc même à 35 ans, on peut avoir un cancer du colutérin. Donc il faut l'entourer. Et bien évidemment, il faut aller faire un examen sous spéculant parce que là on n'a que les données de l'anamnèse, de l'interrogatoire.

(5:44 - 6:17)

Et là pour éliminer un cancer du colutérin, il faut aller faire un examen sous spéculant pour regarder le col s'il n'y a pas une tumeur. Et il faut la biopsier pour avoir une preuve anatomopathologique et confirmer le cancer. Donc récapitulons, 35 ans célibataires ayant un antécédent d'interruption volontaire de grossesse et ensuite une urgence pour des météorologies récentes après un retard de règle.

(6:18 - 6:41)

Donc on a dit que le cancer du lendemain, c'est un cancer qui survient beaucoup plus après les 40 ans et c'est un cancer de la femme ménopausée. Un nouveau enregistrement clandestin, oui, parce qu'il a déjà fait une interruption volontaire de grossesse. Une grossesse extra-utérine, toujours il faut l'évoquer chez la femme en période d'activité génitale.

(6:41 - 6:59)

L'embole hidatiforme, c'est une grossesse particulière par dégénérescence du trophoblaste. Et un cancer du col, bien évidemment, il faut l'évoquer et peut-être l'éliminer après l'examen clinique du colutérin. Parce que là, j'ai que l'anamnèse.

(6:59 - 7:21)

Donc on va passer toujours dans ce cas clinique-là. Donc le deuxième QCM concernant ce cas clinique-là. Chez cette patiente, qu'est-ce que je dois faire ? Je réalise en urgence une prise de consomme usuelle.

(7:22 - 7:42)

C'est très important parce que cette patiente-là peut être en état de choc hémorragique. C'est pourquoi il faut prendre le pouls, la tension artérielle et la température qui peut nous orienter aussi vers d'autres histologies. Donc ça, c'est la première des choses.

(7:42 - 7:59)

C'est qu'il faut une prise de consomme usuelle à la recherche d'une intolérance à l'hémodynamique, à soutenuement. C'est quelque chose de capital et il faut le faire en urgence. Donc il faut entourer cette proposition.

(7:59 - 8:37)

La deuxième proposition, proposition B, faut-il faire une hystéroscopie diagnostique en urgence ? L'hystéroscopie diagnostique, on le fait soit au cabinet, soit au bloc opératoire. C'est un examen où on visualise l'endomètre, la cavité utérine par caméra. Et il se fait un sous- rendez-vous pour, quand on suspecte une pathologie intracavitaire type polype d'endomètre, fibrome intracavitaire.

(8:38 - 8:51)

C'est un examen qui se fait toujours après les données de l'échographie. Donc ce n'est pas un examen qu'il faudra faire en urgence. Donc là, B, c'est faux, c'est une proposition fausse.

(8:51 - 9:08)

Il ne faut pas demander une hystéroscopie diagnostique en urgence sur cette patiente-là. Il faut faire un examen sous spéculum. Oui, il faut le faire parce qu'il va nous éliminer un cancer du col.

(9:08 - 9:29)

Si on voit que l'examen du col est normal, on élimine déjà le cancer du col. Et puis on va voir que le saignement provient de l'orifice externe du col pour dire que c'est réellement des

météorologies. On va éliminer bien évidemment les hydrocauses, les causes cervicales et les causes vaginales.

(9:30 - 10:01)

Donc il faut faire cet examen en urgence contre une patiente saine. Donc il faut entourer la réponse C. Et puis, est-ce qu'il faut faire un test urinaire de grossesse? Comme je le dis, je le répète, à chaque fois qu'il y a une symptomatologie génécologique chez une patiente en période d'activité génitale, obligatoirement, il faut éliminer une grossesse. Donc il faut faire au moins un test urinaire de grossesse.

(10:01 - 10:27)

Sinon, il faut faire un dosage de bêta-ACG plasmatique pour éliminer une grossesse parce qu'il s'agit d'une réelle urgence. Donc il faut faire le test de grossesse, soit urinaire ou plasmatique. L'échographie dans ces situations-là fait presque partie de l'examen clinique.

(10:28 - 10:52)

Donc on ne peut pas continuer notre enquête étiologique sans faire une échographie pélvienne, parfois suspibienne et parfois endovaginale surtout. Parce que dans les grossesses jeunes, on risque de ne rien voir, parfois suspibienne. Donc il faut faire l'échographie parfois endovaginale.

(10:53 - 11:05)

Donc je récapitule. Donc si cette patiente, je dois réaliser une urgence, je dois voir la tolérance hémodynamique par les constantes usuelles. Pas de stéroscopie parce que là, c'est un examen qui se fait en deuxième intention.

(11:06 - 11:39)

Examen sous spéculum, bien évidemment, pour voir l'origine du saignement et éliminer une étiologie vaginale ou cervicale. Faire un test urinaire de grossesse, c'est très important parce que toute symptomatologie gynécologique doit faire éliminer un problème de grossesse. Et bien évidemment, faire une échographie pélvienne qui doit faire toujours un parti des explorations paracliniques des ménométraux arrachés.

(11:39 - 11:47)

Donc la réponse, je fais une urgence. A, prise de constantes usuelles. C, un examen sous spéculum.

(11:48 - 12:07)

D, un test urinaire de grossesse. E, une échographie vaginale. La seule proposition qui est

fausse, c'est B. Donc on va passer à la troisième question pour ce cas clinique là.

(12:12 - 12:30)

Alors là, j'ai fait l'examen. L'examen au spéculum note l'origine intra-utérine du saignement, donc ça vient de l'utérus, et l'absence de lésion cervicale. Et au cours de l'échographie, la patiente présente un malaise.

(12:30 - 13:04)

Donc il y a une chute tensionnelle au cours de l'examen. Donc quel est le diagnostic le plus plausible ? Donc vous avez là, quand je dis le diagnostic le plus plausible, il faut entourer une seule proposition. Donc soit un cancer de l'endomètre, soit un avortement clandestin, soit une grossesse extra-utérine, soit un fibromyoma, soit un cancer du col utérin.

(13:04 - 13:28)

Donc je rappelle, c'est une femme de 35 ans, qui a des notions d'IVG, d'interruption volontaire de grossesse, et qui saigne après un retard de règle. Et quand j'ai fait l'examen, l'examen au spéculum montre qu'il n'y a pas de lésion cervicale. Et au cours de cet examen, la patiente fait un choc hémorragique.

(13:28 - 13:45)

Donc quel est le diagnostic le plus plausible ? Parce que c'est une réelle urgence. Donc vous pouvez répondre comme ça. Je suis en train de regarder vos réponses, donc il faut répondre en même temps.

(13:50 - 14:09)

Donc là je vois quelqu'un qui met la réponse D, un fibromyoma. Un fibromyoma ne donne presque jamais d'état de choc hémorragique. Donc c'est des patientes qui saignent petit à petit, et on fait l'examen en général au cours d'une consultation normale.

(14:11 - 14:35)

Je vois aussi la réponse B. Non, là il peut saigner. Il peut aussi faire un état de choc, mais dès à l'admission. Mais là je demande un seul diagnostic.

(14:40 - 14:57)

Donc il faut faire très attention, je dois le répéter encore. La grossesse extra-utérine, c'est une urgence vitale. Donc en général, la grossesse va se développer dans la trompe, et à un moment donné, la trompe va s'éclater.

(14:57 - 15:18)

Donc il y a une déchirure des vaisseaux, et ça va donner un hémopéritoine, un saignement au niveau de la grande cavité abdominopelvienne. Il va faire un état de choc, et si on ne fait pas l'hémostase, il risque de mourir par l'hémorragie. Donc ça c'est quelque chose dont je n'ai pas envie de voir.

(15:19 - 15:30)

Il y a plusieurs réponses là. Mais il faut le mettre dans la tête. Le premier diagnostic, c'est la grossesse extrautérine.

(15:31 - 16:02)

En fait, c'est une rupture de la grossesse extrautérine qui va être responsable de ce malaise et des chutes tensionnelles. Donc le diagnostic le plus plausible est la réponse C. Monsieur, on a dénoncé des amas et une hémorragie intra-utérine. Pourquoi on a une grossesse extrautérine? Parce que la trompe communique avec l'utérus.

(16:02 - 16:27)

Donc à chaque fois qu'il y a une grossesse extrautérine, il y a un saignement extériorisé au niveau du vagin. Mais surtout, il y a l'hémopéritoine par rupture de la trompe au niveau de la grande cavité, par déchirure d'un vaisseau. Mais on peut ne pas avoir de hémorragie avec un hémopéritoine important.

(16:29 - 16:51)

Donc le saignement extériorisé dans la grossesse extrautérine est souvent minime, mais c'est surtout le saignement interne. C'est clair? Donc c'est l'hémopéritoine qui est responsable du choc hémorragique. Mais le saignement extériorisé en général, c'est un saignement noirâtre et faible.

(16:51 - 17:18)

Mais c'est surtout l'hémorragie interne dans la grossesse extra-utérine. C'est clair ? Donc on va passer à une autre question. Donc là, la patiente fait un état de choc hémorragique.

(17:19 - 17:33)

Il risque de mourir. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'il faut faire en urgence ? J'attends les réponses. La réponse A. Réanimer la patiente.

(17:33 - 17:43)

Demander un groupage sanguin et un hémogramme. Numération formule sanguine. Attendre le dosage bêta-HCG plasmatique qui risque de prendre du temps.

(17:44 - 17:54)

Demander une stéioscopie diagnostique. Ou réaliser une cul-de-synthèse. C'est-à-dire une ponction de cul-de-sac et de glace.

(17:54 - 18:08)

Pour voir s'il y a un saignement, un hémopéridone. On le fait au bloc opératoire. Donc il est là.

(18:08 - 18:22)

Plusieurs réponses sont possibles. Donc là, c'est une patiente en état de choc hémorragique. Bien évidemment, la première des choses à faire, c'est de réanimer la patiente.

(18:22 - 18:29)

Prendre une voie veineuse et commencer le remplissage. D'accord ? En attendant le reste. Donc réanimer.

(18:30 - 18:38)

La première proposition est juste. Réanimer la patiente. Prendre une bonne voie veineuse périphérique.

(18:38 - 18:45)

Commencer le remplissage. Et en même temps, demander un bilan. Donc ce qui nous amène à la deuxième proposition.

(18:47 - 18:58)

Bien évidemment, cette patiente qui est en état de choc hémorragique risque d'être transfusée. Donc on risque de demander du son. Donc il faut avoir le groupage sanguin en urgence.

(19:00 - 19:12)

Un hémogramme pour voir l'hématocrite, l'hémoglobine. Donc ça c'est quelque chose d'extrême urgence. Réanimer, voie veineuse.

(19:13 - 19:24)

Commencer le remplissage. En attendant le groupage et l'hémogramme. Pour démarrer éventuellement une transfusion sanguine chez cette patiente là.

(19:25 - 19:51)

Après, là, on doit faire le dosage de bêta-CG pour confirmer qu'il s'agit bien d'une grossesse. Mais là, en situation d'extrême urgence, il ne faut pas attendre le dosage de bêta-CG. Peut-être qu'il faut faire le prélèvement, mais attendre le résultat de bêta-CG qui peut prendre une demi-heure ou une heure.

(19:52 - 20:07)

Non, parce que c'est une situation d'extrême urgence. Donc on ne doit pas attendre le dosage de bêta-CG. Alors, la proposition C est fausse.

(20:08 - 20:20)

On peut faire le dosage, mais il ne faut pas attendre. Là, le piège c'est attendre. Il ne faut pas attendre ici, il faut agir, parce que c'est une situation d'extrême urgence.

(20:20 - 20:41)

La réponse B, la proposition D, demander une celluloscopie diagnostique. Alors là, c'est une proposition assez difficile. C'est une bonne chose, parce qu'on va faire le diagnostic de la grossesse extra-utérine et en même temps la traiter.

(20:42 - 21:21)

Mais le problème là, c'est qu'il est en état de choc hémorragique et une celluloscopie ne peut pas être réalisée en cas d'intolérance hémodynamique. Mais c'est une réponse un peu difficile pour vous et je ne pense pas que je vais vous demander ça. Et puis, donc ça c'est une réponse fausse, sauf des fois, on fait un remplissage, on stabilise la patiente et on peut faire à ce moment-là la celluloscopie diagnostique et opératoire en même temps.

(21:22 - 21:41)

Mais la celluloscopie, on la fait après la stabilisation de l'état hémodynamique de la patiente. Donc là, normalement, c'est une proposition fausse. La dernière proposition, c'est de réaliser une cul-de-synthèse au bloc opératoire.

(21:41 - 22:33)

Si une patiente a une forte suspicion de grossesse extra-utérine et qui fait un état de choc hémorragique, probablement par l'hémopéritoine, par une hémorragie interne, donc la meilleure proposition, c'est de faire un spiculum pour accéder au cul-de-sac vaginal postérieur et faire une ponction à l'aiguille, à la sauringue, au bloc opératoire. Alors, si je trouve du sang, je confirme l'hémopéritoine, donc la présence du sang au niveau de la grande cavité abdominopérivienne, et à ce moment-là, on est déjà au bloc opératoire, on va l'opérer en urgence. On va faire une laparotomie pour aller faire l'hémostase et sauver la patiente.

(22:35 - 23:14)

Donc je récapitule dans cette situation. La première des choses, c'est de réanimer, prendre une vaveineuse, l'oxygène, commencer le remplissage, demander en même temps, au cours de la prise de la vaveineuse, un groupe à sanguins et un lémogramme, peut-être faire en même temps le dosage beta-CG, mais on ne doit jamais attendre le résultat, donc la réponse, c'est

qu'elle est fausse. Et puis, dès la celluloscopie diagnostique, dans ces situations, il faut stabiliser la patiente avant de faire ça, donc la réponse, c'est qu'elle est aussi fausse.

(23:16 - 23:37)

Mais j'admets que cette proposition est difficile. À votre stade, je ne mettrai pas des propositions comme ça. Et puis ça, c'est quelque chose de capital, parce qu'on ne doit pas aller attendre le bilan, demander une échographie, tout ça.

(23:37 - 24:11)

Il vaut mieux aller directement au bloc opératoire et faire une cul-de-santé, c'est-à-dire une ponction du cul-de-sac. Si je trouve du sang, je dois l'opérer en même temps. Donc c'est A, B et E. Est-ce qu'on peut avoir une grossesse extra-utérine sans avoir un aimant péritoire ? Oui, c'est possible, mais la complication de grossesse extra-utérine, c'est la rupture de la trompe, la rupture des vaisseaux de la trompe.

(24:12 - 24:33)

Mais en général, il faut faire le diagnostic avant la rupture, donc avant l'aimant péritoire. Est-ce que c'est clair ? La grossesse extra-utérine va commencer à se développer au niveau de la trompe. La trompe est un peu élastique, elle va suivre le développement de la grossesse extra-utérine.

(24:33 - 24:54)

À un moment donné, la trompe ne peut plus, elle va se déchirer et elle va déchirer les vaisseaux avec elle. Si on fait le diagnostic avant la rupture de la grossesse extra-utérine, on fait le diagnostic avant l'aimant péritoire. L'idéal, c'est de faire le diagnostic avant ces situations catastrophiques.

(24:56 - 25:32)

Monsieur, quelles sont les situations où on utilise une cul-de-synthèse ? Les situations où on utilise une cul-de-synthèse, c'est surtout les situations d'urgence. La première situation, la première indication, c'est quand il y a une patiente qui arrive en urgence, en état hémorragique, on suspecte une grossesse extra-utérine, on fait la ponction, si on trouve du sang, c'est que c'est un hémopéritoire, il faut opérer cette patiente. C'est la première situation.

(25:32 - 26:07)

La deuxième situation, c'est tous les problèmes infectieux. Quand il y a un abcès, quand il y a une péritonite, aussi, en cas d'urgence, je fais la ponction de la cul-de-synthèse, si je trouve du pus, il s'agit bel et bien d'un problème infectieux péritonial, et je peux l'opérer. Mais c'est des situations d'extrême urgence, quand il est en état de choc infectieux.

(26:07 - 26:41)

Mais déjà, à l'échographie, il va nous montrer le penchement, la nature du penchement, il va nous orienter vers une autre étiologie. Mais la cul-de-synthèse, il trouve sa place surtout dans les extrêmes urgences, quand il y a une rupture de grossesse extra-utérine, une rupture d'un kyste hémorragique au niveau de l'ovaire, ou quand il y a une péritonite, et je ne peux pas me permettre d'attendre, faire un scanner ou autre chose. Si je fais une cul-de-synthèse et que je trouve franchement du pus, il faut aller opérer cette patiente en urgence.

(26:43 - 27:09)

S'il vous plaît, Monsieur, cette cul-de-synthèse va-t-elle être faite après avoir stabilisé l'étalement dynamique de la patiente? Non, pas forcément, parce que c'est juste une aiguille. On peut à quelqu'un, dans ces situations-là, il faut plusieurs personnes. Une personne qui va prendre la voie veineuse, l'autre qui va faire la demande de prise de sang, et l'autre qui fait l'examen.

(27:10 - 27:24)

C'est un examen sous spiculum, avec juste une ponction à l'aiguille. Je n'ai pas besoin d'anesthésie, de rien. Je peux la faire sans problème, en extrême urgence.

(27:25 - 27:44)

D'accord, Monsieur, merci beaucoup. Donc la réponse ici, c'est A, B et E. A, B, E. Pour la réponse C, attendre. Là, il faut éviter ces pièges.

(27:46 - 28:07)

Et là, la proposition D est un peu difficile, oui. Donc on peut la faire, la celluloscopie, après la stabilisation de la patiente, mais elle ne va pas se stabiliser parce qu'elle saigne à l'intérieur. Donc ça dépend de chaque équipe, mais le plus important, c'est de sauver la patiente.

(28:08 - 28:44)

Il vaut mieux aller faire une laparotomie plutôt qu'une celluloscopie quand il y a une intolérance hémodynamique. Voilà, donc on va passer à notre cas clinique. Donc là, c'est une patiente âgée de 46 ans, 4 enfants, qui a dans ses antécédents une myomectomie, c'est-à-dire qu'il est opéré pour myome, résection de myome, de fibrome ou de léomyome.

(28:44 - 29:23)

Ça désigne la même chose, myome, fibrome ou léomyome. Donc il prend un rendez-vous pour une consultation générale devant la constatation d'une augmentation progressive du volume de l'abdomen. Donc il a 46 ans, grande multipart, une notion de myomectomie, c'est-à-dire du terrestre fibromateux, myomateux, et consulte là, en consultation générale, c'est-à-dire qu'il n'y

a pas d'urgence, donc pour une augmentation progressive du volume de son abdomen.

(29:23 - 30:12)

Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout d'abord, quels sont les diagnostics ? Avant de faire l'examen, avant de faire l'échographie et les examens paracliniques, on doit examiner cette patiente et dans ces situations, 46 ans, il y a encore une période d'activité génitale, multipart, notion de myomectomie, et qu'il consulte le maître symptôme, c'est l'augmentation progressive du volume de l'abdomen. Donc, il faut réfléchir sur les situations qui nous amènent à l'augmentation progressive du volume de l'abdomen. Donc, ces situations peuvent se rencontrer en cas de des éventualités diagnostiques, grossesse normale ou pathologique.

(30:15 - 31:02)

Donc là, elle est en période d'activité génitale, augmentation progressive du volume de l'abdomen, il peut s'agir d'une grossesse, donc c'est très important, il ne faut jamais oublier la grossesse. Donc la première étiologie à évoquer chez cette patiente là, c'est la grossesse. Monsieur, même si on n'a pas un signe d'absence des règles ? Alors, même si des fois la patiente saine, au cours de la grossesse, elle est réellement enceinte, qu'elle soit une grossesse normale ou compliquée, et il y a une augmentation progressive du volume de l'abdomen.

(31:02 - 31:18)

Donc, qu'il saine ou ne saine pas, il faut évoquer ce diagnostic. Ce n'est pas parce qu'il a eu ces règles, ce n'est pas forcément des règles, ça peut être juste des saignements. Donc ça, c'est des pièges qu'il faut éviter.

(31:20 - 31:37)

Un mètre c'est un mètre, c'est l'augmentation progressive du volume. Quel que soit, est-ce qu'il a eu ces règles ou pas, il faut évoquer la grossesse normale ou pathologique. Mais bien évidemment, il faut toujours chercher la date des dernières règles.

(31:39 - 32:08)

Mais ce n'est pas un signe très fiable, parce que même au cours d'une grossesse, la femme est enceinte, elle peut saigner, elle peut prendre ça pour des règles. Donc, c'est pourquoi le mètre symptôme ici, c'est l'augmentation progressive du volume de l'abdomen, présence ou non de saignement, il faut évoquer la grossesse. C'est clair ? La deuxième proposition, c'est l'acide.

(32:08 - 32:38)

Donc ça, c'est classique, augmentation du volume de l'abdomen, il faut évoquer la présence d'un épanchement, l'acide. La troisième proposition, c'est, elle utilise pour les myomateurs. Donc, 46 ans, il a déjà un antécédent de myomectomie, oui, le diagnostic le plus plausible, c'est ça, parce qu'il peut avoir une récurrence à récurrence de fibromes.

(32:38 - 32:51)

C'est le cas le plus fréquent. Donc la réponse, c'est, elle est juste, est un risque polymyomateux. Puis, la proposition D, tumeur de l'ovaire.

(32:51 - 33:13)

Donc à chaque fois, les tumeurs de l'ovaire, elles se développent à l'intérieur de la cavité abdominopelvienne, elles se développent très rapidement. Elles peuvent s'accompagner d'acide, et souvent, elles se manifestent par le maître-symptôme, c'est l'augmentation progressive du volume de l'abdomen. Donc, la réponse D, elle est juste.

(33:16 - 33:53)

Et puis, au niveau pelvien, le cancer du côlon. Donc on peut avoir aussi du côlon segmenté, c'est pas parce qu'on est en gynécologie qu'il ne faut pas évoquer les diagnostics de la pathologie digestive et urinaire, parce que c'est le pelvis. Bien évidemment, oui, on peut avoir un cancer du côlon, segmenté, avec présence d'acide, c'est un stade tardif ou une occlusion carrément, qui va être responsable d'une augmentation progressive du volume de l'abdomen.

(33:53 - 34:41)

Donc, ce qu'il faut entourer, c'est les cinq propositions A, B, C, D et E. On passe à la deuxième question concernant ce cas clinique-là. Donc, quelle est la démarche diagnostique initiale qu'on doit réaliser ? Donc, ma démarche diagnostique initiale doit inclure la réalisation d'un examen abdominal et gynécologique, une colonoscopie, une échographie abdominopelvienne, un scanner abdominopelvien, un dosage de marqueur tumoraux. Donc là, vous devez répondre.

(34:45 - 35:28)

Donc, 46 ans, augmentation progressive du volume de l'abdomen, qu'est-ce que je dois faire ? Initialement, au début, ça c'est la première intention. La majorité d'entre vous a donné la réponse juste. Alors, bien évidemment, un examen abdominal et gynécologique qui va m'orienter vers des histiologies, éliminer d'autres histiologies, et surtout, va orienter les investigations paracliniques.

(35:30 - 35:42)

Est-ce que je dois faire une colonoscopie ? Peut-être oui, mais pas en première intention. Non. D'accord ? Donc, pas de colonoscopie.

(35:42 - 36:04)

Une échographie abdominopelvienne, oui, c'est le maître examen. Donc, qui va nous donner une idée sur l'origine de l'augmentation de la masse. Est-ce que je fais un scanner abdominopelvien ? Je parle de l'enquête, ma démarche initiale.

(36:05 - 36:14)

Le scanner sera orienté par l'échographie. Donc, ce n'est pas en première intention. Des dosages de marqueurs tumoraux ? Non.

(36:14 - 36:50)

Je ne sais pas si c'est une tumeur de l'ovaire ou si c'est un utérus myomateux. Tous ces renseignements-là, je peux les avoir avec A et C. Donc, ma démarche initiale, c'est un examen abdominal et gynécologique et couplé à une échographie abdominopelvienne qui va nous orienter peut-être à faire une colonoscopie, à faire un scanner, un IRM, ou en cas de doute, si je suspecte un cancer de l'ovaire, je fais des dosages de marqueurs tumoraux. Donc, c'est pourquoi, initialement, il faut faire très attention.

(36:51 - 37:10)

Ma démarche initiale, donc, c'est A, C, un examen abdominal et gynécologique et une échographie abdominopelvienne. Ça, c'est quelque chose de capital. Il faut toujours suivre une démarche clinique raisonnable.

(37:10 - 37:20)

Il ne faut pas sauter sur ces examens. Peut-être qu'on sera amené à demander un scanner ou un IRM, mais pas en première intention. Là, je parle de la démarche initiale.

(37:21 - 38:05)

Voilà, donc, la réponse, juste, devant une masse abdominopelvienne, c'est l'examen, l'échographie, et puis, en fonction de l'examen clinique et en fonction des données de l'échographie, je serai orienté vers un utérus polymyomateux, je serai orienté vers une masse abdominopelvienne ou vers une grossesse ou autre zoologie. Et en fonction des données, je peux demander d'autres investigations. Donc, question, la troisième question concernant ce cas clinique-là, l'anamnèse, l'interrogatoire ne révèle pas de signe digestif ou urinaire ni de saignement vaginal.

(38:05 - 39:28)

Et l'examen physique confirme la présence d'une masse ferme arrivant à mi-chemin de l'ombilic et perceptible au toucher pelvien, c'est-à-dire au toucher vaginal et au toucher rectal. Alors, en faveur de l'origine ovarienne de la masse, on retrouve les éléments suivants. Donc là, j'ai fait mon anamnèse, j'ai fait mon examen clinique, quels sont les signes cliniques qui vont m'orienter beaucoup plus vers une origine ovarienne à cette masse ? Est-ce que la notion de la myomectomie dans les antécédents, est-ce que la présence d'un sillon de séparation avec l'utérus, c'est-à-dire la tumeur n'est pas adhérente, n'est pas attachée à l'utérus ? La multiparité, est-ce que la présence à l'échographie d'une double composante solide et

liquide à l'échographie ? Est-ce que par la perception de la masse, par le toucher rectal ? Donc ça, c'est l'analyse fine, simbiologique, qui va nous permettre, voilà, je suis beaucoup plus vers un tumeur de l'ovaire plutôt qu'un utérus myomateur.

(39:30 - 40:12)

Donc, la notion de myomectomie, est-ce que c'est dans les antécédents, est-ce que c'est en faveur d'une origine ovarienne ? Bien évidemment, non. Parce que là, la notion de myomectomie dans les antécédents, elle nous oriente beaucoup plus vers la récurrence de l'utérus myomateur. La présence d'un sillon de séparation avec l'utérus, la proposition B, est-ce qu'une masse qui présente un sillon de séparation avec l'utérus, donc c'est beaucoup plus, elle va nous orienter vers une origine annexielle, plutôt ovarienne.

(40:13 - 40:39)

D'accord ? Donc, la réponse B, elle est juste. L'existence d'un sillon de séparation avec l'utérus nous oriente vers une origine annexielle, d'accord ? Beaucoup plus, ça dépend de l'eau verte ou de la trempe, mais c'est essentiellement l'eau verte. La multiparité, est-ce qu'elle va nous orienter vers l'origine ovarienne ? Bien évidemment, non.

(40:42 - 41:11)

La présence d'une double composante solide et liquide à l'échographie, c'est un signe capital, parce que les autres géologies dont l'utérus myomateur, c'est des masses solides. C'est des masses toujours solides à l'échographie. Donc, il faut la présence d'une double composante solide et liquide à l'échographie, c'est un signe très très important en faveur de l'origine ovarienne de la masse.

(41:13 - 42:14)

La perception de la masse par le toucher rectal. Oui, parce que, mais, c'est pas toujours, c'est pas parce qu'on va toucher la masse, mais s'il n'est pas en rapport avec l'utérus, mais, on peut toucher cette masse par le toucher rectal. Donc, au total, dans le signe du myomectomie, non, l'existence d'un signe en séparation, oui, c'est capital, la multiparité, non, la présence d'une double composante solide et liquide à l'échographie, c'est capital, donc B et D, c'est très important, et puis la perception de la masse par le toucher rectal, surtout en cas de présence de sillon, donc le toucher rectal associé au palpé abdominal.

(42:16 - 42:38)

Donc, mais c'est surtout ces deux signes-là qui sont en faveur de l'origine ovarienne, B et D. S'il vous plaît, monsieur. Les masses utérines sont-elles aussi perceptibles par le toucher rectal ? Alors, il y a des masses qui vont se développer à l'extérieur de l'utérus. C'est pourquoi j'ai pas voulu vous compliquer les choses.

(42:39 - 43:22)

Il y a des masses, par exemple, des fibromes, on parle des fibromes sous-serreux, à développement en dehors de l'utérus, et qui vont se prêter à confusion, à un diagnostic différentiel, avec des masses annexielles, et qui sont perceptibles aussi par le toucher rectal associé au palpé abdominal. Mais en général, si on a à l'échographie des composants solides et kystiques à l'échographie, avec une masse latérohutérine, c'est l'ovaire, c'est sûr. Mais si, par exemple, j'ai une masse latérohutérine en dehors de l'utérus qui est solide.

(43:23 - 43:48)

Donc là, il y a un diagnostic différentiel avec l'origine ovarienne ou l'origine utérine, alors qu'il y a réellement un sillon de séparation. Donc ça pose un diagnostic différentiel, mais ça c'est un peu compliqué pour vous. C'est pourquoi sillon de séparation c'est beaucoup plus l'origine annexielle.

(43:49 - 44:10)

Mais surtout à l'échographie double composante, c'est l'origine annexielle. Et puis s'il y a une masse solide en dehors de l'utérus, ça peut toujours être un fibrome sous serreux, qu'il soit pédiculé ou sessile, et qui pose le diagnostic différentiel avec une masse solide ovarienne. Voilà.

(44:16 - 44:36)

Donc on va passer à notre chapitre sur les locorées. Alors les locorées, c'est les pertes vaginales. C'est un symptôme qui est très très fréquent, que ce soit au médecin général ou chez le gynécologue.

(44:37 - 45:03)

Et souvent, il y a deux origines à ces locorées. Soit que vous avez des origines, une origine physiologique, et ça c'est quelque chose de capital, mais malheureusement en pratique quotidienne, on voit que c'est des patients traités à tort pour ces locorées qu'ils doivent être respectés. Donc la première des choses devant ces pertes vaginales, c'est de dire est-ce que c'est physiologique ou c'est pathologique.

(45:03 - 46:05)

Ça c'est quelque chose de capital. Donc il faut les connaître par cœur. Donc là, je demanderai quelles sont les caractéristiques des locorées.

Donc c'est quelque chose de capital. Est-ce que c'est les locorées physiologiques qui sont d'origine cervico-vaginale? Est-ce qu'ils sont inodores? Est-ce qu'ils peuvent s'accompagner de prurites avec des lésions de grattage au niveau de la vulve? Est-ce qu'ils sont de couleur claire ou opalescent? Est-ce qu'ils peuvent s'exagérer en période périovulatoire? Donc ça c'est quelque chose de capital. Bien sûr, ils sont d'origine cervico- vaginale par la glaire au niveau du

col et par la desquamation des cellules vaginales au moment des cellules vaginales et surtout par la transsudation au moment des rapports sexuels.

(46:06 - 46:31)

C'est pourquoi des fois ça dérange et la dame elle vient et elle vous dit ah là j'ai des pertes vaginales et surtout ça me dérange au cours des rapports sexuels et souvent les médecins donnent un traitement. Non, il faut les respecter, il ne faut jamais les traiter sinon on risque d'aboutir à d'autres effets. Donc la réponse A, oui.

(46:32 - 46:44)

B, est-ce que ils sont inodores? Oui, ils n'ont pas d'odeur. Quand c'est mal odorant, il faut suspecter une infection. Donc ils sont par définition inodores.

(46:45 - 47:36)

Est-ce qu'ils peuvent s'accompagner de prurites? Jamais. En cas de prurite, il faut aller chercher une infection. Leur couleur, elle est claire ou pas laissante et elle s'exagère en période périovigatoire par l'imprégnation hormonale.

Donc les locaux biophysiques évoquent l'imprégnation, ils signent l'imprégnation hormonale estrogénique. Donc la réponse là, je vois que la majorité, pas la majorité, tout le monde avait bien répondu, c'est A, B, D et E. C'est juste une proposition fausse. Donc là, c'est une question qui ne pose pas de problème.

(47:38 - 49:00)

Donc on va passer au dernier QCM et après je vais prendre des questions si vous en avez. Donc là, entourer les situations pathologiques chez la femme où le toucher rectal peut être indispensable, c'est-à-dire quand est-ce que je dois faire le toucher rectal, parce qu'en général, je fais mon interprétoire, l'examen gynécologique, c'est l'inspection vivopérinale, l'examen suspéculum et le toucher vaginal associé au palpé abdominal. Mais des fois, je dois faire le toucher rectal.

Quelles sont ces situations-là? La première proposition, une masse pélvienne chez une vierge. La deuxième proposition, en cas de grossesse normale. La troisième proposition, un endométriose sévère.

La quatrième proposition, un cancer utérin. Et la dernière proposition, aucune n'est juste. Donc le toucher, je vous rappelle l'endométriose, c'est la présence du tissu endométrial en dehors de l'endomètre, d'accord? Donc c'est la présence ectopique et qui est, s'il est localisé au niveau du myomètre, ça s'appelle l'adénomyose, ou l'endométriose interne.

(49:00 - 49:31)

Mais souvent, il touche les ovaires et il peut donner des kystes ovariens qu'on appelle endométrium, ou kystes endométriosiques. Mais ils peuvent toucher aussi ce qu'on appelle l'endométriose profonde, ils peuvent toucher la cloison rectovaginale, qui sont responsables de douleurs atroces, surtout au moment des règles et des rapports sexuels. C'est ça l'endométriose.

(49:31 - 49:53)

Donc l'endométriose sévère, par définition, il va toucher la cloison rectovaginale. Donc maintenant, quelles sont les réponses? Je ne sais pas si vous pouvez toujours rectifier ou pas. Donc je vois plusieurs réponses là.

(49:55 - 50:21)

Et même certains, ils ont entouré eux, c'est par erreur ou je ne sais pas. Ils ont entouré, ce ne peut pas être des réponses associées. Si on met A, on ne peut jamais mettre E. Donc en fonction de ces explications, vous pouvez répondre.

(50:23 - 50:41)

Alors certains, ils ont mis B. Donc il faut des situations pathologiques. La grossesse normale, elle n'est pas une situation pathologique. D'accord? Donc il faut, il y a des fois, on met quelques pièges au niveau des réponses.

(50:41 - 50:51)

Donc là, il ne faut pas mettre, c'est faux. Moi je parle des situations pathologiques. En plus, en cas de grossesse normale, on fait le toucher vaginal.

(50:51 - 51:16)

Pourquoi je veux faire un toucher rectal? Non. Donc la première réponse qui est claire, une masse pelvienne, c'est une vierge. Je ne peux pas faire du toucher vaginal sur la vierge, je le remplace par le toucher rectal, pour préciser les rapports de cette masse avec l'utérus ou les annexes, et les rapports postérieurs de cette masse.

(51:16 - 51:30)

Donc, vrai. Première indication, c'est la vierge. Quand j'ai besoin d'explorer le pelvis sur la vierge, je remplace le toucher vaginal par le toucher rectal.

(51:32 - 52:05)

En cas de grossesse normale, je parle des situations pathologiques. Bien évidemment, la grossesse est explorée par le toucher vaginal associé par l'épée abdominale, pas par le toucher rectal. Je viens d'expliquer l'endométriose sévère, profonde, qui touche la cloison recto-

vaginale.

On explore l'endométriose par le toucher rectal associé au toucher vaginal. Donc le toucher rectal est indispensable dans l'exploration de l'endométriose sévère. Et puis le cancer utérin.

(52:05 - 52:22)

Le cancer utérin, il va se propager derrière vers le rectum. Il faut voir s'il y a un envahissement du rectum. Et puis en latéral, on peut explorer par le toucher rectal, l'extension latérale vers les paramètres.

(52:23 - 52:43)

C'est quelque chose de capital à l'examen, capital le toucher rectal en cas de cancer pelvien. Donc la réponse, bien évidemment, c'est A, C et D. A, C, D. Mais je vois que la majorité ont rectifié. Bravo.

(52:45 - 53:03)

Donc c'est le genre de questions que je peux vous poser. Mais il faut faire toujours, il faut être, il faut avoir un raisonnement clinique vers les symptômes. Mes questions seront beaucoup plus faciles que ça.

(53:03 - 53:21)

Mais là, j'ai un peu, je vous ai mis dans une situation parfois difficile pour comprendre le raisonnement clinique. Voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute.

(53:21 - 53:50)

Sinon, on arrête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Bon courage. Donc mes questions seront beaucoup plus orientées vers le raisonnement clinique et facile.

(53:52 - 54:00)

Bon courage à vous en cette période difficile. Du courage et bonne continuation. Au revoir.